체중 치료 주사와 혈압

티르제파타이드·세마글루타이드를 쓰는 동안 어지럼과 혈압을 함께 살펴봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 기억할 세 가지

두 약의 부작용 보고를 비교한 연구이며, 혈압약을 대신한다는 뜻은 아닙니다.

01

티르제파타이드 — 방향이 둘

티르제파타이드 사용군에서 높은 혈압 관련 부작용은 비교군의 0.40배로 적었고, 낮은 혈압 관련 보고는 2.45배로 많았습니다. 고용량군은 2.58배(95% 범위 1.38–4.81)였지만 용량이 오를수록 위험이 늘어난다고 단정할 수는 없습니다.

증량 뒤 일어설 때 어지럼 확인

02

세마글루타이드 — 뚜렷한 차이 없음

세마글루타이드 사용군의 높은 혈압 관련 보고는 비교군의 0.81배, 낮은 혈압 관련 보고는 1.39배였습니다. 두 결과 모두 뚜렷한 차이가 확인되지 않았습니다.

'중립'은 이 지표에 한정

03

이것은 부작용 보고입니다

이 숫자는 혈압이 몇 mmHg 내려갔는지 말해 주지 않습니다. 실제 혈압 변화는 다른 시험에서 따로 살폈습니다.

약제 선택 규칙으로 쓰지 않기

실천 · 혈압약을 함께 먹는다면 주사를 시작하거나 증량할 때 꼭 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

연구에서는 무엇을 살폈나요

32개 시험, 47,332명. RR은 비교군을 1로 볼 때의 부작용 보고 비율입니다.

연구에서 비교한 증상	비교군을 1로 볼 때	환자가 기억할 뜻
티르제파타이드 · 높은 혈압 관련 보고	**0.40배** (95% 범위 0.26–0.60)	비교군보다 적게 보고됐습니다.
티르제파타이드 · 낮은 혈압 관련 보고	**2.45배** (95% 범위 1.35–4.45)	**비교군보다 많이 보고됐습니다.**
티르제파타이드 · 고용량 사용군의 낮은 혈압	**2.58배** (95% 범위 1.38–4.81)	고용량군에서도 많았지만 용량을 올릴수록 늘어난다고 단정할 수는 없습니다.
세마글루타이드 · 높은 혈압 관련 보고	0.81배 (95% 범위 0.57–1.15)	비교군과 뚜렷한 차이가 확인되지 않았습니다.
세마글루타이드 · 낮은 혈압 관련 보고	1.39배 (95% 범위 0.81–2.36)	비교군과 뚜렷한 차이가 확인되지 않았습니다.

실천 · 연구 수치는 내 혈압의 변화량으로 받아들이지 마세요.

출처 · 마지막 장

숫자의 뜻을 정확히 읽어야 합니다

부작용 보고 비율은 실제 혈압이 몇만큼 떨어졌는지를 뜻하지 않습니다.

측정된 것

이 연구는 치료 중 생긴 부작용을 비교한 것입니다. 혈압계로 잰 수치의 변화량은 아닙니다.

이 연구만으로 알 수 없는 것

이 연구의 부작용 보고 비율만으로 혈압이 몇 mmHg 내려가는지는 알 수 없습니다.

혈압 강하 효과는 따로 보고돼 있다

실제 혈압 변화는 다른 시험에서 보고됐습니다. 여기에는 그 수치를 싣지 않았습니다.



실천 · 어지럼이 있으면 앉은 혈압과 일어선 혈압을 기록해 오세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이 연구로 알 수 없는 것

이 연구에서 보고하지 않은 결과를 효과 없음으로 해석할 수 없습니다.

연구에서 본 약과 결과	근거의 확실성	비교군을 1로 볼 때	이렇게 읽으세요
세마글루타이드 · 사망·심장혈관 문제·부작용	판단 불가	**결과가 보고되지 않음**	효과가 없다는 뜻은 아닙니다.
티르제파타이드 · 사망·심장혈관 문제·부작용	판단 불가	**결과가 보고되지 않음**	효과가 없다는 뜻은 아닙니다.
비교 약 오를리스타트 · 심한 부작용	보통	1.45배 (1.10–1.91)	비교군보다 많이 보고됐습니다.
비교 약 오를리스타트 · 전체 부작용	매우 낮음	1.13배 (0.84–1.54)	차이를 단정하기 어렵습니다.
비교 약 펜터민·토피라메이트 · 전체 부작용	보통	1.13배 (1.08–1.20)	비교군보다 많이 보고됐습니다.
비교 약 날트렉손·부프로피온 · 전체 부작용	보통	1.69배 (1.58–1.80)	비교군보다 많이 보고됐습니다.
비교 약 날트렉손·부프로피온 · 전체 사망	매우 낮음	0.99배 (0.70–1.40)	차이를 단정하기 어렵습니다.

실천 · 연구에 없던 결과는 진료에서 따로 확인해야 합니다.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

주사량을 늘린 뒤 혈압도 확인하세요

특히 티르제파타이드 주사량을 늘린 뒤 어지럼을 확인합니다.



① 혈압약을 먹는 분이 증량했다면

고용량군에서도 낮은 혈압 관련 부작용이 비교군의 2.58배로 보고됐습니다. 일어설 때 어지러운지 확인하세요.

② 앉은 자세 → 일어선 뒤 혈압

용량을 올리는 진료 때 혈압을 재고, 일어설 때 핑 도는지 이야기하세요.

③ 혈압약 감량이 필요한지 다시 봅니다

메스꺼움 때문에 식사나 물 섭취가 줄었다면 함께 알려 주세요.

실천 · 주사 용량을 올린 뒤 서 있을 때 어지러운지 살펴보세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 때는 진료실에 알려 주세요

앉았다 일어설 때 어지러운지, 먹고 마시는 양이 줄었는지 살핍니다.

① 혈압약 복용 중 증량했다면

용량을 올린 뒤 일어설 때 어지럽다면 진료실에 알려 주세요. 낮은 혈압 관련 부작용이 고용량군에서도 더 보고됐습니다.

② 기립성 저혈압 병력·고령·이뇨제

이 연구는 고령자와 이뇨제를 먹는 분의 결과를 따로 보고하지 않았습니다. 위험이 없다는 뜻은 아닙니다.

③ "혈압약 대신 쓰자"는 확대 해석

이 자료만으로 이 주사를 혈압약 대신 쓰는 것은 뒷받침되지 않습니다.

④ 소화기 증상과 겹치는 저혈압

계열의 흔한 부작용은 경증·일과성 위장관 반응입니다. 섭취가 줄면 저혈압이 악화될 수 있어 혈압도 같이 봅니다.

실천 · 의식을 잃었다면 바로 응급실로 가세요. 심한 어지럼은 진료실에 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

체중 효과와 혈압 변화를 따로 봅니다

어떤 약을 쓸지는 체중·혈당·몸 상태를 함께 보고 정합니다.

체중 변화

당뇨병이 없는 비만 성인을 비교한 연구에서는 티르제파타이드가 체중을 **더 크게** 줄였습니다.

- 10 mg: 세마글루타이드 대비 체중 **−4.85%**
- 15 mg: 세마글루타이드 대비 체중 **−6.26%**
- 당뇨병이 있는 분에게 그대로 적용할 수는 없습니다
- 연구의 이해관계는 마지막 참고 장에서 확인할 수 있습니다

vs

낮은 혈압 관련 증상

티르제파타이드 사용군에서는 **비교군보다** 낮은 혈압 관련 부작용이 많이 보고됐습니다.

- 티르제파타이드: 비교군의 **2.45배**
- 세마글루타이드: 비교군의 1.39배, 뚜렷한 차이 없음
- 이 숫자로 두 약의 차이를 직접 판단할 수는 없습니다
- 혈압 하나만 보고 약을 고르지 않습니다

실천 · 체중만 보고 혈압약이나 주사약을 바꾸지 마세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

속이 불편할 때도 살펴보세요

메스꺼움으로 식사·수분이 줄면 어지럼이 심해질 수 있습니다.

98,693명

102개 임상시험에 참여한 사람들입니다. 가장 흔한 부작용은 대체로 가볍고 지나가는 위장 증상이었습니다.

저혈당과 메스꺼움도 살펴보세요

연구에서는 이 계열 전체에서 저혈당 위험이 낮았습니다. 별도로, 허가사항은 인슐린·설폰요소제와 함께 쓸 때 저혈당에 주의하도록 안내합니다. 메스꺼움으로 먹고 마시는 양이 줄면 어지럼이 심해질 수 있습니다.



실천 · 구토·설사로 물을 못 마신다면 진료실에 알려 주세요. 소변이 거의 나오지 않거나 정신이 흐려지면 응급실로 가세요.

출처 · 마지막 장

일어설 때 핑 도는 경우

설명용 가상 사례입니다. 약 조정은 본인 진료에서 결정합니다.



사례

용량을 올린 지 3주 뒤 어지럼

설명용 사례: 62세 남성, 당뇨 8년, 체질량지수 31, 혈압약 두 가지를 복용하며 티르제파타이드 용량을 올리는 중입니다.

확인

증량 시점과 겹치나요?

주사량을 늘린 날짜와 어지럼이 시작된 날짜를 비교합니다. 고용량군의 낮은 혈압 관련 보고는 비교군의 2.58배였습니다.

확인·선택

혈압과 섭취량

앉았다 일어선 뒤 혈압과 먹고 마시는 양을 확인합니다. 혈압약 용량이나 주사 증량 속도는 담당 의사와 상의합니다.

실천 · 사례의 처방 조정은 따라 하지 말고 담당 의사와 상의하세요.

출처 · 마지막 장

연구에 아직 답이 없는 질문

아직 따로 측정되지 않은 사람과 결과가 있습니다.

이 자료로 답하기 어려운 질문	진료실에서는 이렇게 확인합니다
혈압이 몇 mmHg 내려가나요?	여기 제시한 연구는 부작용 보고를 비교했습니다. 실제 혈압 변화는 다른 연구와 본인의 측정 기록으로 확인해야 합니다.
오래 쓰면 심장에 어떤가요?	이 자료에 제시한 연구만으로 장기 심장혈관 결과를 판단할 수 없습니다. 담당 의사에게 본인의 위험을 물어보세요.
국내 권고에는 맞나요?	이 자료만으로 국내 최신 권고를 확인할 수 없습니다. 처방 전에 담당 의사가 확인합니다.
용량을 어떻게 바꾸나요?	여기에 용량이나 다른 약과의 조합표는 없습니다. 처방전대로 쓰고 스스로 바꾸지 마세요.
한국인에게도 같은가요?	인용 연구에 참여한 분들의 인종·체형 분포를 이 자료에서는 검증하지 않았습니다.

실천 · 고령이거나 이뇨제를 먹는다면 증상을 더 자세히 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

참고한 연구

자세한 출처는 이 장에서 확인할 수 있습니다.

인용 4건

1. [1] Effect of tirzepatide and semaglutide on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. *Endocrine* · 2026. PMID:42603240
2. [2] Long-term effects of weight-reducing drugs in people with hypertension. *Cochrane Database Syst Rev* · 2026. PMID:42318855
3. [3] Efficacy and safety of incretin-based therapies in patients with type 2 diabetes mellitus: a network meta-analysis based on clinical trials. *Front Pharmacol* · 2026. PMID:42394981
4. [4] Comparison of Clinical Efficacy and Safety of Tirzepatide, Liraglutide and Semaglutide in Patients with Obesity and Without T2D: A Bayesian Network Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. *Adv Ther* · 2026. PMID:41820778

이해관계

[2] 포함 8건 중 **7건이 제약사 후원**(원문 명시) · [4] 저자 다수가 **Eli Lilly 소속**(원문 저자 소속 기재).

원문 노트

티르제파타이드·세마글루타이드와 혈압 — 개원가 근거 노트 (2026-08-18)

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 같은 자료를 다시 열 수 있습니다.

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

이 자료의 성격

체중·혈당 치료 주사와 혈압에 관한 환자 설명자료입니다. 약을 바꾸거나 혈압약을 줄일지는 담당 의사와 상의하세요.

참고한 자료

Endocrine 2026 · Cochrane 2026 · Front Pharmacol 2026 · Adv Ther 2026 · Mounjaro/Ozempic 허가사항(저혈당 주의)

SCAN TO REVISIT

휴대폰에서 다시 보기

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다